

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú, Decana de América

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Escuela Académico Profesional de Odontología



**NIVEL DE ANSIEDAD EN ADULTOS FRENTE A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA
EN EL CENTRO DE SALUD CHACRA COLORADA – LIMA 2025**

BACHILLER:

TORRES PEÑA, MARIA DEL ROSARIO

ASESORA:

CASTRO RODRIGUEZ, ANTONIA FLORENCIA

Lima, Perú, 2025

INDICE

1. TITULO DE PROYECTO	4
2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.....	4
2.1 ÁREA DEL PROBLEMA.....	4
2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA	5
2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	6
2.4 OBJETIVOS	7
2.4.1 Objetivo general.....	7
2.4.2 Objetivo específico	7
2.5 FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN	7
2.6 JUSTIFICACIÓN.....	7
2.7 LIMITACIONES.....	8
3. MARCO TEORICO	8
3.1 ANTECEDENTES.....	8
3.2 BASE TEORICA	12
3.2.1. Ansiedad	12
3.2.1.1 Causas y factores de riesgo de la ansiedad.....	14
3.2.1.2 Síntomas de la ansiedad.....	15
3.2.2 Ansiedad dental.....	15
3.2.2.1 Causas de la ansiedad dental.....	17
3.2.2.2 Criterios para detectar ansiedad odontológica (43).....	18
3.2.2.3 Niveles de ansiedad dental	19
3.2.2.4 Abordaje en el consultorio odontológico.....	19
3.2.3 Medición de la Ansiedad Dental.....	22
3.2.3.1 Escala de Ansiedad Dental Versión Corta (SDAI)	22
3.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES	24
3.4 DEFINICIÓN DE COVARIABLES	24
3.5 MATRIZ DE OPERALIZACIÓN	25
4. METODOLOGIA	27
4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.....	27

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA	27
4.2.1 Población	27
4.2.2 Muestra.....	27
4.2.2.1 Criterios de inclusión.....	28
4.2.2.2 Criterios de exclusión.....	28
4.3 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA.....	28
4.3.1 Selección de muestra.....	28
4.3.2 Recolección de datos.....	29
4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS	30
5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.....	31
5.1 RECURSOS	31
5.2 PRESUPUESTO.....	31
5.3 FINANCIACIÓN.....	32
5.4 CRONOGRAMA.....	32
6. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA.....	33
7. ANEXO 1	39

1. TITULO DE PROYECTO

Nivel de ansiedad en adultos frente a la atención odontológica en el Centro de Salud Chacra Colorada, Lima 2025

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.1 ÁREA DEL PROBLEMA

El envejecimiento de los seres vivos es una realidad inevitable e irreversible; es un proceso universal, continuo, degenerativo, intrínseco y natural que implica cambios físicos, psicológicos y sociales. En Perú, la esperanza de vida de la población está en aumento y según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el año 2020, la población peruana alcanzó los 32.6 millones de habitantes. La esperanza de vida promedio de los peruanos es de 76.9 años: los hombres con una edad promedio de 74.1 años y las mujeres, con 79.5 años; observando una mejora en comparación con los datos del año 2015, donde la esperanza de vida era de 72 años y 77.3 años respectivamente. Sumado a eso, se reporta que la población peruana menor de 15 años descendió de un 24.9% a un 15.5%; mientras que la población adulta es representada por un 66.1%, con un total de 21 millones 571 mil habitantes peruanos, pero se estima que en el año 2025 aumentará a un valor de 66.2% (1).

Con estas cifras se entiende que, en el país, la población ha alcanzado un promedio de edad superior en comparación con tiempos anteriores, generando un aumento en la demanda de atenciones de salud en los adultos, ya que con el avance de edad surgen problemas sistémicos y odontológicos que deben de ser tratados.

El Ministerio de Salud (MINSA) informa que, en el año 2019, el 90.4% de peruanos presentaba lesiones cariosas y el 85% padecía enfermedades periodontales; sin embargo, solo el 45% de la población peruana ha visitado al odontólogo en ese año. Esta situación no ha mejorado en los últimos años debido a la llegada del COVID-19 (2), cifras que aumentaron desde inicio de pandemia, ya que el uso prolongado de mascarillas ha exacerbado las condiciones dentales; además, la frecuencia de cepillado disminuyó significativamente debido a una menor preocupación por la higiene oral, contribuyendo al aumento de enfermedades dentales (3).

Las enfermedades orales tienen un origen multifactorial, presentando factores de riesgo que podrían aumentar el desarrollo de problemas orales; actualmente, la caries y la enfermedad periodontal son las enfermedades más frecuentes en la población. El consumo de golosinas, bebidas con alto consumo de carbohidratos y deficiencia de higiene oral; además, el tabaquismo, enfermedades sistémicas, el uso de medicamentos y cambios hormonales son algunos factores asociados a estos problemas orales. La omisión en la reducción de estos factores podría predisponer estas patologías orales, lo que implicaría acudir con mayor frecuencia a consultas odontológicas y un contacto más frecuente con diversas situaciones previas al tratamiento odontológico, como la estancia en la sala de espera y experiencias durante la atención clínica, tales como el sonido de la fresa, olor de algunos materiales dentales y el uso de anestésicos: estos factores suelen desencadenar ansiedad dental, fenómeno relevante que podría ser un obstáculo en el tratamiento odontológico, generando el abandono o cese de la atención clínica. (4–8)

2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

La inasistencia a la consulta odontológica resulta un problema relevante en el cuidado de la salud oral debido a las consecuencias negativas que representa. Las principales causas que influyen en la ausencia a consultas y tratamientos odontológicos son los factores socioeconómicos, culturales, geográficos y demográficos. (9)

La ansiedad es un factor real por el cual existe un ausentismo en las atenciones odontológicas, este fenómeno influye en el estado oral, ya que entorpece el manejo del paciente durante la atención dental y la adherencia al tratamiento (10); como lo demuestran las investigaciones realizadas en el 2018 donde concluyen que los pacientes que sufren de ansiedad durante tratamientos estomatológicos tiene como resultado la no adherencia al tratamiento provocando problemas en la salud bucal; entonces, el manejo de la ansiedad es un factor a considerar para el éxito del tratamiento odontológico. Además, estudios realizados en el año 2019 demuestran que existe ansiedad dental previo a la atención estomatológica, puesto que todos los participantes en el estudio mostraron ansiedad en diferentes niveles (11,12).

Con lo antes expuesto, se infiere que la psicología y la odontología son disciplinas del área

de la salud que deben complementarse y debe existir un trabajo interdisciplinario para garantizar el bienestar del paciente. El control de la conducta de pacientes que sufren ansiedad ante un tratamiento odontológico juega un rol importante, ya que puede ser un determinante para que el tratamiento odontológico del paciente concluya y sea exitoso. Superar este obstáculo en el paciente es difícil, sobre todo cuando no se identifica la ansiedad previa atención, siendo esto una dificultad frecuente para el odontólogo y ocasionando un impacto considerable en la salud oral.

La ansiedad es un estado emocional normal ante determinadas situaciones, es definida como un fenómeno que puede ser caracterizado por sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación que son experimentados por un individuo en un momento particular. Está asociado a ciertas afecciones del estado mental, social y salud general de la persona. Se puede presentar una ansiedad normal, que es adaptativa a las circunstancias de la vida y se da como respuesta ante situaciones de amenaza que permite tener mayor prudencia frente a situaciones peligrosas; también existe la ansiedad patológica, que se presenta con un temor difuso, pues se está a la espera de una situación negativa futura provocando un malestar en el individuo. (13)

En la atención clínica odontológica, ya sea en el sector público o privado, es posible experimentar experiencias negativas; estas irán construyendo ideas negativas, convirtiéndose en un factor determinante para el aumento de la ansiedad ante tratamientos odontológicos. Por ello, la ansiedad es considerada como un gran obstáculo para lograr el éxito terapéutico, a pesar de los avances tecnológicos y científicos, convirtiéndose en un reto para la Odontología actual. Ferreira *et al.*, mencionan que los niveles de ansiedad aumentan por factores que componen la atención odontológica, tales como el sonido de las turbinas, olor de los materiales dentales, aplicación de anestesia, el adormecimiento de la boca y el tiempo prolongado en la ejecución del tratamiento. (14,15)

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el nivel de ansiedad en adultos frente a la atención odontológica en el Centro de Salud Chacra Colorada, Lima 2025?

2.4 OBJETIVOS

2.4.1 Objetivo general

- Determinar el nivel de ansiedad en adultos frente a la atención odontológica en el Centro de Salud Chacra Colorada, Lima 2025.

2.4.2 Objetivo específico

- Determinar el nivel de ansiedad en adultos frente a la atención odontológica según el género, Lima 2025.
- Determinar el nivel de ansiedad en adultos frente a la atención odontológica según la edad, Lima 2025.
- Determinar el nivel de ansiedad en adultos frente a la atención odontológica según el grado de instrucción, Lima 2025.

2.5 FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN

Este trabajo de investigación cuenta con los recursos necesarios para poder ser realizado, con el financiamiento necesario para su ejecución. El plan de trabajo asegura que todos los aspectos involucrados en la ejecución de este estudio estén bien organizados y alineados con los objetivos de investigación.

2.6 JUSTIFICACIÓN

Actualmente, la ansiedad afecta a un alto porcentaje de la población peruana, ya que juega un papel importante para el manejo de conducta del paciente en la atención oral, pues si durante la atención surge este trastorno ansioso puede entorpecer la atención del paciente trayendo como consecuencia un tratamiento ineficiente y en el peor de los casos, un mal tratamiento.

La identificación del nivel de ansiedad presente permitirá determinar la presencia de este fenómeno y con ello la necesidad de realizar y ejecutar protocolos de atención especial para las personas que sufren de ansiedad, se debe hacer la distinción entre los protocolos de

atención según los niveles de ansiedad del paciente, pues el manejo de conducta en los distintos niveles de ansiedad no es la misma. Además, se debe recalcar que la atención bucal no es la misma en adultos jóvenes que en adultos mayores.

Esta investigación permitirá conocer el nivel de ansiedad en los pacientes y factores que propician el desarrollo de ansiedad dental, de esta manera se podrá mejorar ciertos aspectos de la atención odontológica con el objetivo de reducir y prevenir el abandono del tratamiento actual y de futuros tratamientos. Además, los resultados de esta investigación serán relevantes pues proporcionará información al Centro de Salud para dar a conocer la problemática actual de ansiedad dental en los pacientes y de esta manera, mejorar la atención odontológica servirá también como referencia valiosa para futuros estudios.

2.7 LIMITACIONES

Para el desarrollo de esta investigación es importante que la población esté dispuesta a responder la encuesta proporcionada. Además, la sinceridad de los participantes al responder cada ítem es esencial. Por otro lado, se debe tener en cuenta el número de pacientes que acuden a sus citas en el turno y horario acordados.

3. MARCO TEORICO

3.1 ANTECEDENTES

Pinto. et al. 2022, realizaron un estudio para determinar el nivel de ansiedad antes del tratamiento odontológico en pacientes adultos atendidos en el consultorio dental Pinto's de la ciudad de Huaura. Estudio no experimental, transversal y prospectivo; se trabajó con 245 pacientes adultos y se les aplicó la encuesta Escala de Ansiedad Dental Modificada de Corah (MDAS). Como resultado, se encontró que la ansiedad leve prevaleció en una parte significativa de la muestra. (16)

Sarango y Villavicencio en el 2021, realizaron un estudio para determinar la frecuencia de ansiedad al tratamiento dental en adultos del Cantón Saraguro, Ecuador. Estudio de tipo

observacional, descriptivo y transversal; en el cual se trabajó con 403 adultos, se les aplicó una encuesta para identificar y medir la ansiedad dental. Para evaluar la frecuencia de la ansiedad al tratamiento dental se utilizó el cuestionario validado EQ-SDAI. Como resultado, se evidenció la prevalencia de ansiedad dental en un 78.16%, es decir, la prevalencia de ansiedad al tratamiento odontológico fue relativamente alta. (17)

Quispe en el año 2020, realizó un estudio para determinar el nivel de ansiedad en pacientes adultos atendidos en el servicio de odontología del Centro de Salud de San Pedro de Cusco. Estudio descriptivo, observacional y transversal; en el cual se trabajó con 126 adultos, se les aplicó la encuesta Escala de Ansiedad Dental Versión Corta SDAI. Como resultado, se evidenció ansiedad dental leve, además, no se encontraron diferencias estadísticas significativas entre edad, género tipo de tratamiento y grado de instrucción. (18)

Mena. et al. 2020, realizaron una investigación con el fin de evaluar los niveles de ansiedad relacionados a los tratamientos odontológicos en pacientes que acuden al consultorio dental del Centro de Salud "La Península"- Ecuador. Estudio no experimental, transversal y descriptivo; en la cual se trabajó con una población de 248 pacientes adultos. Para evaluar los niveles de ansiedad dental emplearon el instrumento Test de Corah Modificado. Como resultado, se encontró que el 68% de mujeres y el 32% de hombres presentaron ansiedad, y el procedimiento odontológico que causa mayor ansiedad con 39% fueron las exodoncias. (19)

Coronel. 2020, realizó un estudio para determinar los niveles de ansiedad en pacientes adultos previo a su atención clínica y su relación con la edad, género y tipo de tratamiento dental en el Centro de Salud del Distrito de Ciudad Nueva-Tacna. Estudio observacional, epidemiológico, descriptivo y transversal; en el cual se trabajó con 250 pacientes y se les aplicó la encuesta Corah Modificada y el Test de Imagen Facial. Como resultado, prevaleció ansiedad leve, los adultos jóvenes presentaron mayor ansiedad que los otros grupos de edad, mostrando mayor nivel de ansiedad frente a los tratamientos de exodoncia. (20)

Castillo. et al. en el año 2019, investigaron si existe una asociación entre el grado de instrucción y la ansiedad dental en la parroquia Monay de la ciudad de Cuenca- Ecuador, se realizó un estudio de tipo caso-control; la muestra conformada por 360 pacientes adultos entre

18 y 44 años. Para evaluar el grado de ansiedad dental se utilizó el instrumento EQ-SDAI. Como resultado, el sexo femenino, pacientes entre 21 a 30 años, personas con nivel educativo alto presentaron mayor ansiedad (54%); sin embargo, al uso de la prueba estadística Odds Ratio (0.6977 IC 95 %: 0.4585-1.059), se concluye que no existe asociación entre el grado de instrucción y la ansiedad dental.(21)

Cáceres. et al. en el año 2019, en su investigación determinaron el grado de ansiedad frente a tratamientos de operatoria dental y cirugía bucal en un hospital de Lima-Perú. Estudio observacional, transversal, descriptivo; en el cual se trabajó con una población de 144 pacientes adultos, 72 pacientes por especialidad. Para determinar el grado de ansiedad se utilizó el instrumento validado, Inventario de ansiedad de Beck (Beck Anxiety Inventory - BAI), se encontró un similar nivel de ansiedad en pacientes ante tratamientos de operatoria dental y cirugía bucal.(22)

Ramírez. et al. en el año 2019, en México, realizaron un estudio para determinar el nivel de ansiedad previo a su atención odontológica en el primer nivel de atención. Estudio descriptivo y transversal, seleccionaron por conveniencia a 37 hombres y 72 mujeres. Para determinar el nivel de ansiedad se aplicó el instrumento Escala de Ansiedad de Corah Modificada (MDAS). Como resultado, se obtuvo que el 47.70% presentó un nivel de ansiedad leve y 37.61% un nivel de ansiedad moderada previo a la atención odontológica.(12)

Sinha. et al. en el año 2019, en India, con el propósito de evaluar el nivel de ansiedad frente a los tratamientos odontológicos en centros de salud primario. Estudio transversal; evaluaron a una población de 100 pacientes adultos. Para evaluar el nivel de ansiedad dental presente en pacientes adultos, se utilizó el cuestionario validado Escala de Ansiedad de Corah Modificada (MDAS). Como resultado, se encontró que un 94% de ellos mostraron niveles de ansiedad, evidenciando que las mujeres se mostraban significativamente ansiosas, además mostraron un mayor nivel de ansiedad tras la aplicación de inyección (55%), raspaje dental (45%) y operatoria dental (40%), concluyendo que la ansiedad dental era alta entre los participantes. (23)

Ferreira. et al. en el año 2018, en Paraguay, analizaron el nivel de ansiedad de los pacientes que acudieron a consultas en una clínica odontológica de una empresa privada de servicios

odontológicos. Estudio transversal; en el cual se trabajó con 297 adultos y se les aplicó una encuesta para analizar el nivel de ansiedad dental, para su evaluación se utilizó el cuestionario Escala de Ansiedad Dental de Corah Modificada (MDAS). Como resultado, se encontró que el 17.85 % de los participantes presentaron ansiedad elevada y el 17.85 % severa, además que la inyección de anestésicos generó mayores niveles de ansiedad con un 40.40%.(15)

Córdova y Santa María en el 2018, realizaron una investigación para determinar el nivel de ansiedad en pacientes que acudieron a la clínica odontológica de una universidad peruana. Estudio no experimental y transversal, en la cual se encuestaron a 120 adultos aplicando la escala de Ansiedad Dental versión corta (SDAI). Como resultado, se encontró que el 43.3 % presentó ansiedad leve, el 20% ansiedad moderada y el 16.7% ansiedad severa, se evidenció mayor frecuencia de ansiedad al preparar el carpule con la inyección de anestesia 23.4%. (24)

Pereyra en el 2018 realizó un estudio para determinar el nivel de ansiedad dental en la atención odontológica en los pacientes adultos que acudieron a la Clínica Docente Asistencial de la Facultad de Odontología de la UNMSM. Estudio observacional, transversal, retrospectivo y descriptivo; en el cual se trabajó con 150 pacientes y se les aplicó la Escala de Ansiedad Dental Modificada de Corah (MDAS). Como resultado, se encontró que el 45% de los pacientes adultos presentó un nivel de ansiedad leve o nulo y se evidencia relación inversa entre el nivel de ansiedad con respecto a la edad y al nivel educativo, sin encontrarse relación con el sexo ni el tipo de atención recibida. (25)

Quichimbo y Serrano en el 2017, realizaron un estudio para relacionar la frecuencia de la ansiedad al tratamiento odontológico con el nivel de instrucción presentes en los adultos de 45 a 65 años, en la parroquia Totoracocha en la ciudad de Cuenca-Ecuador. Estudio descriptivo; en el cual se trabajó con 351 adultos y se les aplicó una encuesta EQ-SDAI para evaluar el nivel de ansiedad dental. Como resultado, se encontró que el sexo femenino presenta un nivel alto de ansiedad dental; además los pacientes con el nivel de instrucción bajo mostraron mayor ansiedad dental con un 60% en comparación con los pacientes con un nivel de instrucción alto. (26)

Cázares. et al. 2015 realizaron un estudio con el objetivo del determinar el nivel de ansiedad

dental de los pacientes y evaluar la asociación con variables: escolaridad, ocupación, el tipo de tratamiento y la clínica donde se atendieron. Estudio no experimental, transversal, descriptivo y de asociación; en el cual trabajó con 203 pacientes (73 varones y 130 mujeres) de entre 15 y 64 años, se les aplicó una encuesta para evaluar la ansiedad dental. Para determinar el nivel de ansiedad dental se utilizó el Inventario de Ansiedad Dental versión corta. Como resultado, se evidenció la prevalencia de ansiedad dental en un 32% en las mujeres y un 17% en los hombres, pero no tuvo asociación estadísticamente significativa con el género, escolaridad, ocupación, tratamiento, y clínica.(27)

3.2 BASE TEORICA

3.2.1. Ansiedad

El termino ansiedad proviene del latín *anxiētas*, la Real Academia Española (RAE) conceptualiza el termino ansiedad como "Angustia que suele acompañar a muchas enfermedades, en particular ciertas neurosis, y que no permite sosiego a los enfermos"(28).

En la década de los años cincuenta las investigaciones psicológicas giraban en torno al trastorno mental de la esquizofrenia, en los años setenta el interés psicológico cambió y su enfoque se dirigió hacia la depresión, en la década de los ochenta, los psicólogos Husain y Jack Maser afirman que es la década de la ansiedad, este trastorno surgió en 1985 y desde entonces ha sido un tema vigente hasta el día de hoy(29).

El concepto de ansiedad con el tiempo ha ido evolucionando, al inicio fue considerado como un estado emocional transitorio, se valoró como rasgo de la persona o justificación de la conducta del individuo. Mowrer en 1939 afirma que tiende a ocurrir de forma irracional, en otras palabras, no necesariamente existe un peligro real. Desde ese año se dieron múltiples conceptos de la ansiedad tomando en cuenta la parte subjetiva, Kolb en 1968 plantea que los "Ataques de ansiedad", son causados por hiperventilación, respiraciones entrecortadas, aturdimiento y sensación de desvanecimiento y pasos inseguros, esto implica que el exceso de respiraciones rápidas puede desencadenar síntomas asociados a la ansiedad(29).

El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud propuso que la ansiedad es un estado emocional negativo que esta caracterizado por la existencia de sentimientos desagradables,

acompañado de pensamientos incómodos o perturbadores y actividades corporales ligadas a respuestas autónomas del cuerpo. Freud consideró que para hablar de ansiedad se debe de considerar los fenómenos subjetivos y fisiológicos, pero consideró relevante al fenómeno subjetivo, pues propone que en la consciencia se desarrolla la ansiedad(29).

En 1971, Freud desarrollo una teoría compleja de la ansiedad, formando como parte de su trabajo sobre el psicoanálisis y distinguió tipos de ansiedad según su origen y su relación con los procesos psíquicos, los cuales lo clasifica como:

- **Ansiedad real:** es el resultado de cuando sentimos peligro a nuestro alrededor, es nuestra señal de advertencia, surge como respuesta ante una amenaza externa real y objetiva. Esta ansiedad no tiene origen en el inconsciente, sino una respuesta a situaciones externas.
- **Ansiedad neurótica:** resulta ser complejo, la señal de peligro proviene de los impulsos reprimidos, el motivo no está claro, pero la ansiedad está relacionada con los recuerdos de castigos o eventos traumáticos reprimidos del pasado, la persona presenta una mayor ansiedad de expresar estos impulsos reprimidos porque teme ser castigada nuevamente, En resumen, el yo intenta complacer al ello, sin embargo, esas peticiones o exigencias lo hacen sentir amenazado y teme del que yo no pueda controlar al ello.
- **Ansiedad moral:** está relacionada a la culpa o vergüenza; ya que el superyó, amenaza al yo con la probabilidad de perder el control sobre los impulsos. Este tipo de ansiedad surge cuando una persona siente que esta violando sus principios morales y su actuar es inaceptable según la ética.

Por consiguiente, se infiere que, de todas las teorías psicológicas (30)as, el psicoanálisis fue una de las teorías con una convergencia significativa, ya que sus fundamentos formaron una base sólida para el desarrollo de conceptos en el campo de la psicología, dejando en evidencia que el psicoanálisis sigue siendo relevante para el estudio y comprensión de la ansiedad(29).

En la actualidad la ansiedad es una de las enfermedades mentales que lleva afectando a más de 700 millones de personas, actualmente, los trastornos psicológicos más comunes son la ansiedad y la depresión(31), la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que el 3.6%

de la población mundial sufre de ansiedad, aproximadamente 264 millones de mujeres padecen este trastorno. Actualmente, se registra un incremento de casos, influenciado por el aumento en el número de la población, desde el año 2005 al 2015, se estima un aumento del 14.9% en consecuencia del crecimiento y envejecimiento de la población(32).

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) define el término ansiedad como un estado que nos permite estar alerta, característica necesaria en ciertas situaciones, en niveles leves nos da la capacidad de tener precaución en circunstancias de peligro y en un nivel moderado nos permite estar concentrados para la toma de mejores decisiones(33).

3.2.1.1 Causas y factores de riesgo de la ansiedad

La ansiedad se establece como un trastorno con múltiples causales y también con factores de riesgo(33,34) que podrían desencadenar su padecimiento como:

- **Factor Biológico**
 - **Genética:** la predisposición genética puede ser un factor de transmisión de la ansiedad de una generación a otra.
 - **Consumo de drogas:** el consumo de sustancias estupefacientes y cafeína puede causar ansiedad.
- **Factor psicológico**
 - **Traumas:** personas que han pasado por situaciones traumáticas suelen tener un mayor riesgo de padecer ansiedad en el transcurso de sus vidas, estos traumas en su mayoría se originan en la infancia.
 - **Estrés:** el padecer una enfermedad grave o el tener problemas de salud provoca constantes preocupaciones del tratamiento establecido y su evolución, además, eventos importantes, el estrés laboral, estrés académico y las dificultades económicas, también pueden provocar una ansiedad excesiva.
- **Factor social**
 - **Experiencias:** no son situaciones traumáticas, pero si forman parte de nuestra vida, cambios repentinos, pueden causar ansiedad, este sentimiento en menor grado es normal pues nos mantiene alerta, se convierte en un problema cuando es frecuente, intenso y no existe motivo, además limita las actividades de la

persona en su día a día.

3.2.1.2 Síntomas de la ansiedad

Existen signos y síntomas por los que podemos identificar la ansiedad, ya que este trastorno se manifiesta a nivel emocional y físico:

Manifestaciones emocionales: preocupación excesiva y constante, irritabilidad, tensión, inquietud, inconvenientes para mantenerse concentrado o tomar decisiones, dificultad para conciliar el sueño, constante cansancio(33).

Manifestaciones físicas: sudoración excesiva, pulso cardíaco elevado, tensión muscular, náuseas, mareos y desmayos(33).

3.2.2 Ansiedad dental

La ansiedad dental es la expresión utilizada para describir el miedo relacionado a la atención odontológica, termino vigente e importante de conocer en nuestra práctica diaria pues la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que al menos el 15% de toda la población presenta ansiedad antes de acudir con el odontólogo(35), pacientes con ansiedad dental tienden a dejar de asistir a sus consultas odontológicas, además, no son receptivos o colaboradores a la atención estomatológica, exponiéndose al deterioro de la condición oral, pues al no darle el correcto tratamiento a sus piezas dentarias tienen como consecuencia, carencia en la calidad bucodental. La ansiedad dental es una razón para evitar las visitas con el odontólogo y esto estará relacionado a un mal estado de salud oral.

Coriat (1946) es quien describe de manera científica el termino ansiedad dental, lo define como "miedo excesivo a cualquier cosa hecha en los dientes", propone a la ansiedad como respuesta a cualquier intento de atención odontológica, en la cual el paciente cancela citas acordadas para recibir atención dental y huye de cualquier situación donde se sostenga una interacción odontólogo-paciente, provocando una deficiente salud oral , entonces, es Coriat en el año 1946, impulsa y establece las raíces históricas científicas sobre ansiedad dental (30).

Berggen en 1984, propone un modelo donde se describe a la ansiedad dental como un círculo

vicioso (36), en la cual, la persona que sufre de ansiedad dental pospone el tratamiento odontológico por un periodo prolongado, y teniendo como consecuencia, efectos negativos en su salud bucal y consigo, un sentimiento de vergüenza y miedo a que lo juzguen por su condición oral. De esto se infiere que la ansiedad dental no solo trae como consecuencia el deterioro de la salud bucal sino también un cansancio mental por los sentimientos negativos que afloran en la persona quien lo padece (37).

Namankany en el año 2012 define a la ansiedad dental como una enfermedad multisistémica, que se da en respuesta de una situación de peligro, es una respuesta individual y subjetiva, convirtiéndose en un factor condicional para la búsqueda y aceptación para la realización de los servicios odontológicos, este fenómeno no es exclusivo de género ni edad, pues es experimentado tanto en niños, adultos, hombres y mujeres.

La ansiedad dental actualmente está catalogada como fobia específica, pues se caracteriza por desencadenar síntomas físicos, como sudoración, temblores y agitación, además de síntomas emocionales como el nerviosismo extremo, pánico y disminución de la capacidad de concentración, relacionado a la exposición de un objeto o situación específica, como lo es la atención odontológica (34).

La ansiedad dental es un fenómeno complejo que está caracterizada por un gran nerviosismo, preocupación, acompañados de sentimientos subjetivos de tensión, todo esto lo experimenta el individuo en una circunstancia particular, ya sea antes, durante o después de la atención odontológica (38).

En la actualidad, si bien el término de ansiedad dental ya es reconocido, en la práctica estomatológica aún es difícil identificarla, términos como ansiedad, miedo y fobia, son similares desde el punto de vista conceptual, pero desde el enfoque médico difieren en sus respectivos abordajes, es importante aprender a reconocer sus diferencias para realizar una buena atención odontológica, pues se deben de seguir recomendaciones y realizar protocolos individualizando a los pacientes, existen distintos protocolos que favorecen el abordaje del paciente en la atención odontológica, estos pueden ser invasivos y no invasivos, además, dependiendo del paciente se debe actuar multidisciplinariamente para llegar a tener éxito.

3.2.2.1 Causas de la ansiedad dental

La base de la ansiedad se encuentra en la conciencia (39) la ansiedad dental es un fenómeno complejo, existen varias causas por las cuales se puede dar este fenómeno, Lizardi y Jimenez (2012) mencionan diversos factores que pueden dar lugar a la ansiedad dental (40):

- Características de la personalidad del paciente, el paciente puede tener temor a las heridas, sangre, dolor, además puede presentar experiencias dentales negativas o tener influencia de personas cercanas que padecen de ansiedad dental.
- Relación odontólogo- paciente, puede existir una vaga o nula comunicación entre el odontólogo, personal asistencial y el paciente.
- Relación entre el equipo del establecimiento odontológico, el personal con mal humor, con poca o nula empatía con los pacientes, personal poco amigable para con el paciente favorecen el incremento de incomodidad en el paciente.
- Factores ambientales y experiencia del paciente, los olores y ruidos propios del consultorio, la ambientación de la sala de espera, tiempo de espera, quejas de otros pacientes.
- Durante el procedimiento odontológico, factores que pueden desencadenar ansiedad dental es la falta de información del procedimiento, falta de sensibilidad en la atención y el tiempo prolongo de la atención odontológica.

Por otro lado, autores como el Dr. Gutiérrez y Cázares de León (2019) quienes hacen mención a más factores (41) que podrían desencadenar la ansiedad dental como lo son:

- Ruido del equipo
- Aspecto de los materiales odontológicos
- Duración de la atención odontológica
- Inmovilidad del paciente en la atención odontológica
- Aspecto del consultorio odontológico
- Rasgos y conductas del personal odontológico
- Contagiarse de alguna enfermedad haciendo uso del instrumental odontológico
- Sufrir lesión en la boca durante el tratamiento odontológico

Estos factores están ligados con la ansiedad dental, sin embargo, varios estudios estiman que

el temor al dolor es el principal motivo por el cual se puede desarrollar ansiedad dental, es por ello que evitan realizarse evaluaciones odontológicas, diagnósticos y tratamientos bucodentales, se estima que el antecedente del dolor puede reconstruirse con el tiempo, es decir, los pacientes sobreestiman el dolor, pacientes con un nivel de ansiedad severo tienden a inflar la estimación del dolor antes de recibir la atención odontológica(42).

Para los odontólogos es difícil, estresante y complejo el abordaje de pacientes con ansiedad, el fracaso durante el tratamiento odontológico es una opción si se desconoce o ignora las señales de conductas de ansiedad, pues podemos influenciar el inicio de este trauma en pacientes que no la padecían o aumentar el nivel de ansiedad en pacientes que ya padecen de ansiedad dental.

Ante lo expuesto, la ansiedad dental es catalogado como un trastorno que se origina en la consciencia, es complejo y multifactorial, ocasionando repercusiones en la salud del paciente pues la ansiedad dental genera una disminución del estado de la salud bucodental, ya que al no recibir atención dental básica va a aumentar el número de dientes cariados y también va a aumentar la probabilidad de padecer las enfermedades de las encías y demás, se viene demostrando que este trastorno aumenta la probabilidad del retraso y rechazo a las evaluaciones, diagnósticos y tratamientos odontológicos, todo ello ocasionando un pobre estado en la salud oral del paciente.

3.2.2.2 Criterios para detectar ansiedad odontológica (43)

○ Señales de ansiedad dental

- Indagan frecuentemente sobre el uso de inyectables
- Conversaciones intranquilas con personas a su alrededor
- Cancelación de citas agendadas
- Hipotermia y sudoración
- Dificultad para estar sentado en el área de espera

○ Manifestaciones conductuales de la ansiedad dental

- Poca colaboración con el odontólogo

- Respuestas cortas y precisas
- Gestos de rechazo
- Sudoración excesiva
- Rigidez muscular
- Inquietud de las manos

3.2.2.3 Niveles de ansiedad dental

Leve o bajo: Existe y prevalece una actitud de calma y tranquilidad en la persona, sin embargo, hay una ligera complicación al realizar el examen, diagnóstico y el tratamiento odontológico (14).

Moderado: Este nivel de ansiedad se caracteriza porque el estado de ánimo de la persona presenta confusión o desorientación, existe una actitud de desconfianza, temor y vergüenza, además, hay un aumento de actividad física, caracterizado por movimientos rápidos y descontrolados, acompañado de un gran nerviosismo e incertidumbre, existe un deterioro en el funcionamiento psicológico y habilidades cognitivas o emocionales, por la cual se dificulta el examen odontológico, su diagnóstico y su respectivo tratamiento, en este punto, el odontólogo debe de modificar su rutina de trabajo (14).

Severo o alto: Este nivel esta caracterizado por un temor intenso, acompañado por desesperación, la persona tiene la necesidad de evitar y el querer huir de la situación, existe un gran deterioro del funcionamiento psicológico y habilidades cognitivas o emocionales que obstaculizan la realización del examen odontológico, su diagnóstico y su respectivo tratamiento en la cita programada, forzando el cambio de la cita pactada (14).

3.2.2.4 Abordaje en el consultorio odontológico

Actualmente, es difícil y complejo para el odontólogo el poder identificar a los pacientes que sufren de ansiedad dental, sin embargo, no es imposible, porque existen señales, características y conductas del paciente que podrían darnos un indicio sobre este tipo de trastorno, el identificar un paciente con ansiedad dental es el primer gran paso para poder realizar la evaluación, diagnóstico y el tratamiento odontológico propiamente, identificando al

paciente ansioso, podemos realizar un mejor abordaje en la atención estomatológica, la Dra. Lima en el año 2006 (44) propone lo siguiente:

Control de ansiedad con terapia de comportamiento:

- Dialogar con el paciente antes de la atención odontológica, explicarle de forma clara, concisa y tranquila sobre el tratamiento a realizarle.
- Explicarle al paciente sobre las incidencias que pueden ocurrir si es que este realiza movimientos bruscos durante la atención odontológica
- Programar procedimientos simples en las primeras sesiones odontológicas.
- Tratamiento de relajación
- Terapia de exposición gradual, de esta manera poco a poco el paciente tiene contacto con la situación que desencadena la ansiedad dental logrando así que disminuya algunos síntomas de la ansiedad

Control de ansiedad con terapia farmacológica:

No existe un medicamento exclusivo para el tratamiento de este tipo de fobia específica, sin embargo, los ansiolíticos de elección pertenecen al grupo de benzodiazepinas, estos medicamentos de elección deben de ser administrados 45 minutos antes de que se realicen el tratamiento odontológico, para la administración de estos medicamentos se debe de contar con la prescripción e indicación del especialista.

Nieto *et al* en el año 2019 (45) propuso diversas recomendaciones generales que pueden ser aplicadas en la práctica estomatológica diaria como:

- El tiempo de la consulta odontológica debe de ser adecuado.
- Disminuir o evitar factores provocadores tomando en consideración el principio de las "4S", enfocados en los estímulos aplicados en el sentido de la vista, olfato, oído y tacto:
 - Sentido de la vista, factores como lo son las agujas y las fresas favorecen el aumento de la ansiedad dental.
 - Sentido del olfato, factores como el eugenol, sistemas adhesivos, acrílicos favorecen el aumento de la ansiedad dental.
 - Sentido del oído, factores como el sonido que produce la pieza de alta

velocidad favorecen el aumento de la ansiedad dental.

- Sentido del tacto, factores como el sentir las vibraciones de alta frecuencia favorecen el aumento de la ansiedad dental.
- Implementar métodos de relajamiento.
- Usar distractores como el uso de audífonos.
- Buscar realizar tratamientos interdisciplinarios con especialistas en cognición, conducta o psicólogos para tratamiento de ansiedad y terapia de comportamiento.
- Sedación consciente usando agentes farmacológicos.

Desde el enfoque odontológico, conocer el diagnóstico psicológico del paciente resulta importante para el correcto abordaje del paciente, si bien no podemos diagnosticar trastornos psiquiátricos, podemos incentivar la asistencia de los pacientes a terapias como la psicoterapia ya que esta brinda una enseñanza diferente de como pensar y cómo actuar, cambiando así las reacciones que desencadena la ansiedad, en algunos casos, se recomienda la terapia de exposición ya que permite el control de miedos, esto permite que el paciente confronte las situaciones y no las evite, si es necesario, se debe de acompañar estas terapias con medicamentos(34).

Los métodos para disminuir los factores que provocan el sentido de la vista, olfato, oído y el tacto favorecen en gran parte el reducir la ansiedad dental, además, se recomienda el uso de olores agradables, el uso de colores atractivos en la sala de espera y no hacer esperar al paciente para ser atendido, de manera complementaria la empatía por parte del odontólogo y el personal auxiliar es importante para que el paciente se sienta más cómodo y tranquilo en la atención odontológica, lo ideal es complementar los tratamientos odontológicos con sesiones psicológicas, por último, si fuera necesario se debe de hacer uso de agentes farmacológicos.

Todos los pacientes merecen acudir con el odontólogo y recibir atención dental, si bien es cierto, tratar a pacientes con ansiedad dental demanda mayor tiempo y se deben de tomar mayores consideraciones, tomar en cuenta los puntos mencionados mejora la experiencia de los pacientes, se espera poder tener más puntos a considerar para tener un mejor abordaje en la atención de los pacientes, estas indicaciones ayudan tanto al odontólogo como al paciente en la atención dental.

3.2.3 Medición de la Ansiedad Dental

Actualmente, existen diversos instrumentos para medir la ansiedad dental en niños y adultos, estos instrumentos varían en el enfoque, complejidad y alcance, el instrumento más adecuado será el que se ajuste con las necesidades a evaluar y la población en la que se ejecutará, en resumen, cada instrumento tiene distinciones importantes como:

- **Complejidad del instrumento:** algunos instrumentos pueden ser muy simples elaborado con pocas preguntas o instrumentos elaborados con más preguntas que abordan con mayor detalle aspectos relacionados con la ansiedad dental.
- **Número de ítems:** cada instrumento tiene una cantidad de preguntas determinada, algunos poseen pocos ítems y otros más ítems que están enfocados en aspectos específicos.
- **Enfoque de medición:** existen instrumentos que están diseñados específicamente para la evaluación de ansiedad dental, mientras otros abordan aspectos más amplios.
- **Tipo de respuesta:** las respuestas varían, pues existen cuestionarios con opciones múltiples y cuestionarios elaborados con preguntas abiertas para tener una respuesta con mayor detalle.

Existen varias consideraciones que se deben de tomar en cuenta al elegir que instrumento utilizar para la medición de ansiedad dental en pacientes adultos, uno de los cuestionarios más utilizados en adultos es la Escala de ansiedad dental de Corah (DAS) y la Escala de ansiedad dental modificada (MDAS), por otro lado, el instrumento de Escala de ansiedad dental versión corta es un instrumento, confiable, validado, instrumento fácil y rápido de evaluar la ansiedad en los pacientes, al ser simple el proceso de evaluación es posible la identificación rápida de aquellos pacientes con ansiedad, mejorando así la experiencia del paciente.

3.2.3.1 Escala de Ansiedad Dental Versión Corta (SDAI)

El instrumento de Inventario de Ansiedad dental (SDAI) o también llamado instrumento de autorreporte es una versión corta del instrumento del Inventario de Ansiedad Dental (DAI)(46). y conocido en inglés como Dental Anxiety Inventory's shortened version (SDAI). Fue propuesto

y realizado por Stouthard, Groen y Mellenbergh en el año 1995, validado en inglés por Aartman Irene (47).

El instrumento de Inventario de Ansiedad dental (SDAI) (Gold Stándar) (48) es una encuesta que evalúa la ansiedad dental, siendo uno de los instrumentos más utilizados en investigaciones clínicas, validado en distintos países como: Perú (Córdova y Santa Maria Carlos, 2018) (24), México (Cázares de León et al., 2013), China (Ng, Stouthard & Leung, 2005), Colombia (Caycedo et al., 2008) y Holanda (Aartman, 1998) (49).

Se analiza el realizar una versión corta pues el instrumento del Inventario de Ansiedad Dental (DAI), si bien se logra medir los niveles de ansiedad frente a circunstancias o situaciones de la atención odontológica, está elaborado con 36 ítems, convirtiéndolo en un instrumento muy amplio y poco práctico; sin embargo, la ventaja del desarrollo de este instrumento es que se toman en cuenta las reacciones físicas, pensamiento y comportamiento de la persona (50).

Al ser poco práctico utilizar el instrumento DAI, se analiza y se forma el instrumento SDAI, este consta de nueve ítems de tipo Likert con cinco alternativas de respuestas diferentes como: nunca, pocas veces, algunas veces, muy frecuentemente y siempre. A cada respuesta se le asigna un valor del uno al cinco, luego se realiza una suma total y esta sumatoria debe estar en el rango del 0 al 45, de esta manera podemos realizar la clasificación: sin ansiedad, levemente ansioso, moderadamente ansioso y extremadamente ansioso (51).

El instrumento SDAI presenta múltiples características: solidez conceptual; propiedades psicométricas adecuadas: amplio uso en investigación internacional; clara preferencia por la simplicidad, permitiendo una rápida evaluación del paciente; eficaz, pues evalúa exitosamente la ansiedad dental; útil, cuando son varios pacientes a los que se les debe de aplicar este instrumento; además, resulta fácil interpretar los resultados, permitiendo la identificación de pacientes con ansiedad dental. Por último, ha sido validado en estudios clínicos y se ha podido aplicar en diferentes circunstancias de atención dental, respaldando así la utilidad y fiabilidad como instrumento de evaluación de ansiedad dental.

3.3 DEFINICIÓN DE VARIABLES

Ansiedad: es un estado emocional, caracterizado por preocupación e inquietud, en un nivel leve resulta benéfico favoreciendo el estado de alerta, por otro lado, niveles excesivos de ansiedad pueden perjudicar las actividades diarias del individuo.

Ansiedad dental: preocupación extrema relacionada a la atención odontológica, causando deficiencia de salud bucal.

Escala de Ansiedad Dental Versión Corta (SDAI): cuestionario que mide la ansiedad dental, estructurado con nueve ítems con cinco alternativas de respuesta, cuya puntuación va desde 0 al 45, midiendo el nivel de ansiedad (sin ansiedad, levemente ansioso, moderadamente ansioso y extremadamente ansioso)

3.4 DEFINICIÓN DE COVARIABLES

Género: Característica sexual entre los individuos

Edad: Lapso transcurrido en el individuo desde el nacimiento hasta el momento(52).

Grado de instrucción: Es el grado de estudios más elevado realizado por el individuo(53).

3.5 MATRIZ DE OPERALIZACIÓN

VARIABLE	DEFINICIÓN	INDICADOR	ITEMS	ESCALA	CATEGORIA	VALOR
Nivel de ansiedad frente a la atención odontológica	Estado psicológico que se presenta de manera desagradable, asociado a cambios psicofisiológicos	Reacciones físicas	Pregunta 6 Pregunta 8	Ordinal	• Sin ansiedad <10 • Levemente ansioso 11-19 • Moderadamente ansioso 20-27 • Extremadamente ansioso 28-45	Bajo Medio Alto
		Pensamiento	Pregunta 2 Pregunta 4 Pregunta 7 Pregunta 9			
		Comportamiento de la persona	Pregunta 1 Pregunta 3 Pregunta 5			

COVARIABLE	DEFINICIÓN	INDICADOR	ESCALA	TIPO DE DIMENSIÓN	VALORES
Género	Característica sexual entre los individuos	Encuesta sobre el género	Nominal	Cualitativa	• Masculino (1) • Femenino (2)
Edad	Lapso transcurrido en el individuo desde el nacimiento hasta el momento	Encuesta sobre la edad	De razón	Cuantitativa	• Adulto joven (de 18 a 39 años) • Adulto maduro (entre 40 a 59 años) • Adulto mayor (de 60 a más)
Grado de instrucción	Es el grado de estudios más elevado realizado por el individuo	Encuesta sobre nivel de instrucción	Nominal	Cualitativa	• Sin instrucción (1) • Primaria (2) • Secundaria (3) • Superior (4)

4. METODOLOGIA

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

- Según la manipulación de la variable, la investigación es de tipo observacional ya que las variables no son manipuladas por el investigador.
- Según el periodo y secuencia del estudio, es de tipo transversal ya que la información recolectada se obtiene en un solo momento y en un tiempo determinado.
- Según el tiempo de ocurrencia de la investigación, el presente estudio es de tipo prospectivo porque los datos se van a recoger mediante el uso de encuestas.
- Según la finalidad y el alcance de los resultados es de tipo descriptivo pues describe las características de la ansiedad en determinada población.

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

4.2.1 Población

La población estará conformada por pacientes adultos de 18 años a 65 años que acuden a realizarse un tratamiento odontológico en el Centro de Salud Chacra Colorada.

4.2.2 Muestra

La muestra seleccionada en base a un método probabilístico aleatorio-

Para estimar el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula:

$$n = z^2 \cdot p \cdot q / d^2$$

$$n = (1,96)^2 (0,1)(0,9) / (0,05)^2 = 138,29$$

n: nivel de confianza

p: probabilidad de éxito

q: probabilidad de fracaso (1 -p)

d: precisión o error permitido

El tamaño de la muestra será este de 138,29. Sin embargo, para tener mayores casos para describir se amplía la muestra a 150.

4.2.2.1 Criterios de inclusión

- Pacientes mayores de 18 años a 65 años al área de los Servicios Odontológicos de los Centros de Salud Chacra Colorada a realizarse un tratamiento odontológico en el año 2025.
- Pacientes que decidan participar en la investigación voluntariamente.
- Pacientes que firmen el consentimiento informado.

4.2.2.2 Criterios de exclusión

- Pacientes que sean menores de edad.
- Pacientes que decidieron no participar.
- Pacientes diagnosticados con trastornos psiquiátricos (Esquizofrenia, psicosis, trastornos disociativos)
- Pacientes con condiciones como el trastorno del espectro autista (TEA) o trastorno por déficit de atención (TDAH)
- Pacientes con discapacidad intelectual moderada, grave o profunda que puedan tener dificultades para comprender las preguntas y respuestas.
- Pacientes con ceguera total o sordera que no cuenten con la asistencia necesaria para completar el cuestionario.
- Pacientes con condiciones como parálisis cerebral, paraplejia, cuadriplejia, amputaciones o polio que interfieran significativamente con su capacidad para completar el cuestionario.
- Pacientes que no firmen el consentimiento informado.

4.3 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICA

4.3.1 Selección de muestra

Para la realización de esta investigación se seleccionará a pacientes que cumplen los criterios de inclusión y de exclusión expuestos, además serán incluidos solo a pacientes que permanecen en la sala de espera y en el horario de atención correspondiente en el servicio de odontología del servicio público.

4.3.2 Recolección de datos

La información será recolectada con la participación de los pacientes que se encuentren en la sala del servicio de odontología en el Centro de Salud Chacra Colorada con pacientes que acuden para realizarse algún tratamiento odontológico y se encuentran en espera de ser atendidos. Además de ello, se incluirá únicamente a aquellos que presenten signos y síntomas evidentes de ansiedad dental, tales como sudoración excesiva, temblores, respiración acelerada, rigidez muscular, palpitaciones, movimientos repetitivos (como golpeteo con los pies o manos), expresión facial de angustia o evitación del contacto visual. Estos signos serán observados previamente por el investigador, y servirán como criterio para aplicar el cuestionario de ansiedad dental a quienes cumplan con estas características, siempre previo consentimiento informado.

Si el paciente acepta participar voluntariamente tras haber sido informado sobre el objetivo del estudio, se le entregará el consentimiento informado para que lo lea y firme. Posterior a ello, se le entrega el cuestionario con preguntas generales relacionadas a la edad, sexo, grado de instrucción y 9 preguntas de la Escala de Ansiedad Dental Versión Corta (SDAI) descrito por Stouthard, Goen y Mellenbergh en 1995, instrumento validado por Aartman Irene (47), además, Sotomayor y colab., en el año 2018 determinaron la consistencia interna del instrumento con un alfa cronbach de 0,856. (24)

La encuesta de Escala de Ansiedad Dental Versión Corta (SDAI) tiene cinco opciones de respuesta (siempre, muy frecuente, algunas veces, pocas veces, nunca)

Se brindará un lapso para llenar el cuestionario y la posibilidad de realizar cualquier consulta para resolver dudas que podrían surgir al momento de leer y llenar el cuestionario. Posteriormente, se enumerarán las fichas para poder registrar los datos en el programa estadístico.

La escala SDAI es un instrumento de autorreporte que consta de 9 ítems que evalúan las situaciones relativas al tratamiento odontológico en que el paciente presenta ansiedad, consta de 9 preguntas y cada pregunta con cinco alternativas de respuesta, estas alternativas de respuesta serán las mismas en cada pregunta y a cada una de las alternativas se le atribuye una puntuación:

Respuesta a= 1 punto

Respuesta b= 2 puntos

Respuesta c= 3 puntos

Respuesta d=4 puntos

Respuesta e=5puntos

Para calcular el nivel de ansiedad se realiza la sumatoria de los puntajes obtenidos al finalizar el test y se clasifica:

- Sin ansiedad: 0-10
- Levemente ansioso: 11-19
- Moderadamente ansioso: 20-27
- Extremadamente ansioso: 28-45

Además, para registrar y analizar las demás variables en estudio, se les asignará los siguientes valores:

GRUPO ETAREO:

- Adulto joven de 18 a 39 años = 1 punto
- Adulto maduro entre 40 años a 59 años = 2 puntos
- Adulto mayor de 60 años a más) = 3 puntos

SEXO

- Femenino = 1 punto
- Masculino = 2 puntos

GRADO DE INSTRUCCIÓN

- Sin instrucción = 1 punto
- Primaria = 2 punto
- Secundaria = 3 puntos
- Superior = 4 puntos

4.4 ANALISIS DE RESULTADOS

La información recolectada se adjuntará a una base de datos de software IBM SPSS 21.0 (Statistical Package for Social Sciences,IBM) y en el programa de Microsoft Excel para la

ejecución de tablas y gráficos . Se realizará estadística descriptiva haciendo uso de frecuencias y porcentajes, además de usar tablas cruzadas.

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5.1 RECURSOS

HUMANOS:

- Asesora de trabajo de investigación
- Pacientes adultos de 18 a 65 años que asistan al área odontológica del Centro de Salud Chacra Colorada
- Personal para el manejo estadístico
- Digitador del trabajo de investigación

MATERIAL:

- Internet.
- Laptop.
- Recurso electrónico
- Teléfono celular

TÉCNICOS:

- Oficina administrativa de la clínica odontológica
- Oficina de Apoyo a la docencia e investigación

5.2 PRESUPUESTO

Desglose presupuestario	Monto		
	Monto en soles	Descripción	Total en soles
A. Personal Digitado y codificador de datos Estadística	S/ 600.00	Procesamiento de datos SPSS	S/ 600.00

6. REFERENCIA BIBLIOGRAFICA

1. Instituto Nacional de Estadística e Informática [Internet]. [citado 24 de junio de 2023]. Disponible en: <https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/en-el-2021-ano-del-bicentenario-de-la-independencia-el-peru-contara-con-una-poblacion-de-33-millones-35-mil-304-habitantes-11624/>
2. Ministerio de Salud. El 90.4% de los peruanos tiene caries dental [Internet]. El 90.4% de los peruanos tiene caries dental. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/45475-el-90-4-de-los-peruanos-tiene-caries-dental>
3. Pinzan Vercelino CR, Salvatore Freitas KM, Pereira Girão VM, Oliveira da Silva D, Morais Peloso R, Pinzan A. Does the use of face masks during the COVID-19 pandemic impact on oral hygiene habits, oral conditions, reasons to seek dental care and esthetic concerns? J Clin Exp Dent [Internet]. 2021 [citado 24 de junio de 2023];e369-75. Disponible en: <http://www.medicinaoral.com/medoralfree01/aop/57798.pdf>
4. Zanini M, Tenenbaum A, Azogui-Lévy S. La caries dental, un problema de salud pública. EMC - Tratado de Medicina [Internet]. 1 de marzo de 2022 [citado 30 de agosto de 2023];26(1):1-8. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1636541022460429>
5. Arrieta Vargas LM, Paredes Solís S, Flores Moreno M, Romero Castro NS, Andersson N. Prevalencia de caries y factores asociados: estudio transversal en estudiantes de preparatoria de Chilpancingo, Guerrero, México**. Rev Odont Mex [Internet]. 19 de junio de 2019 [citado 30 de agosto de 2023];23(1). Disponible en: <https://revistas.unam.mx/index.php/rom/article/view/70011>
6. Artigas RS, Sánchez RJS, Romero CRS, Lara AE. Factores de riesgo de enfermedad periodontal. Correo Científico Médico [Internet]. 2021 [citado 31 de agosto de 2023];25(1). Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=104000>

7. Córdova Sotomayor DA, Santa María Carlos FB. Niveles de ansiedad en pacientes adultos de una clínica odontológica en una universidad peruana. Rev Estomatol Herediana [Internet]. 4 de julio de 2018 [citado 14 de mayo de 2024];28(2):89. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/reh/v28n2/a04v28n2.pdf>
8. Solari PBL, Yanovich JSR. Factores que condicionan la deserción de los pacientes en la Clínica Estomatológica de la Universidad Señor de Sipán en el año 2017. Salud & Vida Sipanense [Internet]. 2 de septiembre de 2019 [citado 2 de septiembre de 2023];6(1):22-9. Disponible en: <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/SVS/article/view/1102>
9. Garrido C, Sepúlveda D, Zúñiga R, Cartes-Velásquez R. Inasistencia a citas dentales: una revisión breve de las causas y las estrategias para su prevención. Disponible en: <http://www.scielo.org.pe/pdf/reh/v34n1/1019-4355-reh-34-01-63.pdf>
10. Ríos Erazo M, Herrera Ronda A, Rojas Alcayaga G. Ansiedad dental: evaluación y tratamiento. Avances en Odontoestomatología [Internet]. febrero de 2014 [citado 5 de agosto de 2023];30(1):39-46. Disponible en: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0213-12852014000100005&lng=es&nrm=iso&tlng=es
11. Rodríguez Chala HE, Cázares de León F. Efectos negativos de la ansiedad al tratamiento estomatológico. Revista Cubana de Estomatología [Internet]. diciembre de 2018 [citado 24 de junio de 2023];55(4):1-11. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0034-75072018000400007&lng=es&nrm=iso&tlng=es
12. Ramírez Arriaga AA, Haro Acosta ME, Hernández González C, GastelumVerduzco LG. Nivel de ansiedad en los pacientes previo a su atención dental en el primer nivel de atención.
13. Fernández López O, Jiménez Hernández B, Alfonso Almirall R, Sabina Molina D, Cruz Navarro J. Manual para diagnóstico y tratamiento de trastornos ansiosos. MediSur [Internet]. octubre de 2012 [citado 24 de junio de 2023];10(5):466-79. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1727-897X2012000500019&lng=es&nrm=iso&tlng=es
14. Amaíz Flores AJ, Flores MÁ. Abordaje de la ansiedad del paciente adulto en la consulta odontológica: propuesta interdisciplinaria. OVital [Internet]. 1 de enero de 2016 [citado 24 de junio de 2023];1(24):23-30. Disponible en: <https://revistas.ulatina.ac.cr/index.php/odontologiavital/article/view/256>
15. Ferreira Gaona MI, Díaz Reissner CV, Pérez Bejarano NM, Cueto González NC, Leggio González TG, Cardozo-Lovera LB, et al. Nivel de ansiedad de los pacientes antes de ingresar a la consulta odontológica. Rev Cienc salud [Internet]. 9 de octubre de 2018 [citado 24 de junio de 2023];16(3):478-87. Disponible en: <https://revistas.urosario.edu.co/index.php/revsalud/article/view/7266/6623>
16. Pinto Toscano, Leslie Alexandra, Rosario Valladares, Bettyna Thaely, Torres Inga, Marcela

Noelia. Nivel de ansiedad antes del tratamiento odontológico en pacientes adultos atendidos en el Consultorio Dental Pinto's Huaura - 2022 [Internet] [observacional, descriptivo, transversal y prospectivo.]. Universidad Continental FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Escuela Académico Profesional de Odontología; Disponible en:
https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/14436/2/IV_FCS_503_TE_Pinto_Rosario_Torres_2024.pdf

17. Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, Sarango González MM, Villavicencio Caparo E, Universidad Católica de Santa María, Perú. Prevalencia de ansiedad al tratamiento dental en adultos del Canton Saraguro, Ecuador 2021. Kiru [Internet]. 30 de septiembre de 2022 [citado 2 de julio de 2024];19(3):95-103. Disponible en:
<https://portalrevistas.aulavirtualusmp.pe/index.php/Rev-Kiru0/article/view/2530>
18. Quispe Cáceres, Junior. NIVEL DE ANSIEDAD EN PACIENTES ADULTOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD DE SAN PEDRO, CUSCO 2019. [Internet]. UNIVERSIDAD NACIONAL SAN ANTONIO DE ABAD DEL CUSCO; Disponible en:
https://repositorio.unsaac.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12918/5153/253T20200036_TC.pdf?sequence=1&isAllowed=y
19. Mena Silva PA, Vaca Altamirano GL, Mardaneh Pérez CA. Niveles de ansiedad producidos frente a tratamientos odontológicos en pacientes atendidos en el Centro de Salud la Península, Ecuador. Disponible en:
<https://dilemascontemporaneoseduccionpoliticaayvalores.com/index.php/%20dilemas/article/view/2461/2506>
20. Coronel Roque, Wendy Fernanda. NIVELES DE ANSIEDAD EN PACIENTES ADULTOS PREVIO A LOS TRATAMIENTOS A REALIZARSE EN LOS SERVICIOS ODONTOLÓGICOS DE LOS CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA, TACNA 2019 [Internet]. UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA; Disponible en: <https://repositorio.upt.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12969/1677/Coronel-Roque-Wendy.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
21. Castillo DM. ASOCIACIÓN ENTRE INSTRUCCIÓN Y ANSIEDAD DENTAL: CASO-CONTROL. Odontol Act [Internet]. 17 de diciembre de 2019 [citado 14 de mayo de 2024];4(Esp):1-6. Disponible en: <https://pruebas3.ucacue.edu.ec/index.php/oactiva/article/view/403>
22. Cáceres Alfaro WJ, Hermoza Moquillaza RV, Arellano Sacramento C. Ansiedad y tratamientos dentales en un hospital de Lima, Perú. Rev Med Inst Mex Seguro Soc [Internet]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2019/im192f.pdf>
23. Sinha E, Rekha R, Nagashree S. Anxiety of dental treatment among patients visiting primary health centers. J Indian Assoc Public Health Dent [Internet]. 2019 [citado 14 de mayo de 2024];17(3):235. Disponible en: <http://www.jiaphd.org/text.asp?2019/17/3/235/266754>
24. Córdova Sotomayor DA, Santa Maria Carlos FB. Niveles de ansiedad en pacientes adultos de una clínica odontológica en una universidad peruana. Revista Estomatológica Herediana [Internet]. abril de 2018 [citado 3 de septiembre de 2023];28(2):89-96. Disponible en:

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1019-43552018000200004&lng=es&nrm=iso&tlng=es

25. Pereyra Espichán KJ. Nivel de ansiedad frente a la atención odontológica en pacientes adultos de la Clínica de la Facultad de Odontología de la UNMSM. Universidad Nacional Mayor de San Marcos [Internet]. 2018 [citado 2 de septiembre de 2023]; Disponible en: <https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/7953>
26. Quichimbo Armijos TJ, Serrano Piedra SD. FACTORES ASOCIADOS EN ANSIEDAD DENTAL AL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO EN ADULTOS DE 45 A 65 AÑOS EN LA PARROQUIA TOTORACocha, CUENCA- ECUADOR 2017. Disponible en: <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/SVS/article/view/1002/862>
27. Cázares de León F, Montoya Flores BI, Quiroga García MÁ. Ansiedad dental en pacientes adultos durante el tratamiento dental. Disponible en: <https://www.remexesto.com/index.php/remexesto/article/view/19/31>
28. Real Academia Española. Ansiedad. En: Real Academia Española [Internet]. 23.ª ed. Disponible en: <https://dle.rae.es/ansiedad?m=form>
29. Sierra JC. Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos a diferenciar. 2003;(1).
30. Coriat IH. Dental anxiety: fear of going to the dentist. 1946;365-7. Disponible en: https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Psychoanal%20Rev&title=Dental%20anxiety:%20fear%20of%20going%20to%20the%20dentist&author=IH%20Coriat&volume=33&publication_year=1946&pages=365-367&pmid=20993406&
31. Machado Oliveira D, Brandim De Mesquita Alencar NM, Pereira Costa J, Astrês Fernandes M, Teles De Oliveira Gouveia M, Marques Santos JD. Retiro laboral temporal por trastornos mentales y de comportamiento entre profesionales de enfermería. Rev Cuid [Internet]. 3 de mayo de 2019 [citado 15 de mayo de 2024];10(2). Disponible en: <https://revistas.udes.edu.co/cuidarte/article/view/631>
32. Depression and Other Common Mental Disorders Global Health Estimates.
33. Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). Ansiedad [Internet]. Ansiedad. Disponible en: <https://www.fesemi.org/informacion-pacientes/conozca-mejor-su-enfermedad/ansiedad#:~:text=1.,precauci%C3%B3n%20en%20situaciones%20especialmente%20peligrosas.>
34. Morales Muñoz MO, Ignacio-Victoriano M. Ensayo sobre trastorno de la ansiedad. xikua [Internet]. 5 de enero de 2024 [citado 11 de junio de 2024];12(23):80-5. Disponible en: <https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/xikua/article/view/10899>
35. Arrieta Vergara K, Díaz Cárdenas S, Verbel Bohórquez J, Hawasly Pastrana N. Factores asociados a sintomatología clínica de miedo y ansiedad en pacientes atendidos en Odontología. Rev Clin Med Fam [Internet]. febrero de 2013 [citado 16 de mayo de 2024];6(1):17-24. Disponible

en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-695X2013000100004&lng=en&nrm=iso&tlng=en

36. Berggren U. Dental fear and avoidance: A study of etiology, consequences and treatment. [Goteborg, Sweden: University of Goteborg]; 1984.
37. Cohen SM, Fiske J, Newton JT. The impact of dental anxiety on daily living. BRITISH DENTAL JOURNAL. 2000;189(7).
38. Alcolea García Annet de la Caridad, Alcolea Rodríguez José Rolando, Alcolea García Anais de los Milagros, Palomino Rodríguez Karen Leimys. Odontofobia y su correlación con la salud bucal general y la enfermedad periodontal. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/pdf/mmed/v25n3/1028-4818-mmed-25-03-e1077.pdf>
39. Barreiro Vera, Camily Leonela, Armijos Moreta, Jaime Fernando, Gavilánez Villamarín, Silvia Marisol. La ansiedad dental en pacientes durante un tratamiento odontológico. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/379604174_La_ansiedad_dental_en_pacientes_durante_un_tratamiento_odontologico
40. Gutiérrez Lizardi P, Gutiérrez Jiménez HA. Urgencias médicas en odontología. Segunda edición. México, D.F.: Manual Moderno; 2012.
41. Gutiérrez Lizardi, Pedro, Cázares de León, Francisco. Ansiedad dental y urgencias médicas. 2019 [Internet]. 6(1). Disponible en: <https://www.remexesto.com/index.php/remexesto/article/view/239/441>
42. Hmud R, Walsh. Ansiedad dental: causas, complicaciones y métodos de manejo. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/237649777_Ansiedad_dental_causas_complicaciones_y_metodos_de_manejo
43. Perla Jacaranda De Dienheim Barriguete, Jazmín Sánchez Miranda, Jazmín Bautista Aguilar. Ansiedad en el paciente odontológico. Revista Odontológica Basadrina [Internet]. Disponible en: <https://revistas.unjbg.edu.pe/index.php/rob/article/view/1571/1806>
44. Lima Álvarez, Magda, Casanova Rivero, Yanett. Miedo, ansiedad y fobia al tratamiento estomatológico. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1727-81202006000100007#9
45. Nieto Martínez Brenda Itzel, Salazar Tavaréz Rocío Guadalupe, Rubio Sánchez Areli, Espinoza Chico José Carlos, García Muñoz Alejandro. Manejo del paciente adulto ansioso en el consultorio dental [Internet]. Manejo del paciente adulto ansioso en el consultorio dental. Disponible en: <https://dentistaypaciente.com/punto-de-vista-131.html>
46. Caycedo C, Cortés OF, Gama R, Rodríguez H, Colorado P, Caycedo M, et al. ANSIEDAD AL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS DE GÉNERO. Suma Psicológica. 2008;15.

47. Aartman IHA. Reliability and validity of the short version of the Dental Anxiety Inventory. *Comm Dent Oral Epid* [Internet]. octubre de 1998 [citado 15 de noviembre de 2024];26(5):350-4. Disponible en: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0528.1998.tb01972.x>
48. Villavicencio E, Castillo D, Llapa M, Jaramillo Z, Coronel P, Pariona MDC. Validación de un instrumento de ansiedad dental EQ-SDAI. *Rev Estomatol Herediana* [Internet]. 12 de diciembre de 2019 [citado 15 de noviembre de 2024];29(4):277-84. Disponible en: <http://192.168.18.122/rev3306/index.php/REH/article/view/3636>
49. Cázares de León, Francisco, Moral de la Rubia, José, Montoya Flore, Blanca. Validación del inventario de ansiedad dental versión corta en pacientes adultos mexicanos.
50. Chala HER. Instrumentos para evaluar ansiedad al tratamiento estomatológico en el adulto.
51. Cázares De León F, Lozano Laín AJ, Gutiérrez Lizardi P, Salinas Noyola A. Grados de ansiedad en la extracción de un tercer molar impactado. Diferencias de género / Anxiety Levels during Impacted Third Molar Extraction. Gender Differences. *Univ Odontol* [Internet]. 6 de enero de 2017 [citado 7 de junio de 2024];35(75). Disponible en: <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revUnivOdontologica/article/view/18122>
52. Universidad de Navarra. Edad. En: CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA [Internet]. CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA; Disponible en: <https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/edad#:~:text=f.,juventud%2C%20edad%20adulta%20y%20vejez>.
53. Euskal Estatistika Erakundea, Instituto Vasco de Estadístic. Nivel de instrucción. En Instituto Vasco de Estadística; Disponible en: https://www.eustat.eus/documentos/opt_0/tema_303/elem_11188/definicion.html#:~:text=El%20nivel%20de%20instrucci%C3%B3n%20de,no%20saben%20leer%20ni%20escribir.

7. ANEXO 1



CONSENTIMIENTO INFORMADO

"NIVEL DE ANSIEDAD EN ADULTOS FRENTE A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN EL CENTRO DE SALUD CHACRA COLORADA – LIMA"

Estimado participante, a continuación, se le brinda el Consentimiento Informado por favor léalo cuidadosamente antes de decidir su participación con total libertad sin ser coaccionado o influenciado en el presente estudio.

- Propósito del Estudio:

Lo invitamos a participar del presente estudio titulado "Nivel de ansiedad en adultos frente a la atención odontológica en el Centro de Salud Chacra Colorada- Lima." Este es un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el propósito de determinar el nivel de ansiedad en los adultos frente la atención odontológica. La ejecución de este estudio permitirá identificar el nivel de ansiedad en los adultos frente la atención odontológica.

- Procedimiento:

Si de manera voluntaria desea participar en este estudio se le entregará una encuesta que deberá de completar, toda información proporcionada será tratada de manera confidencial.

La encuesta estará conformada por preguntas de sus datos personales tales como: genero, edad y grado de instrucción

De igual manera, se le realizarán las 9 preguntas relacionadas al nivel de ansiedad frente a la atención odontológica, preguntas específicas para la investigación.

Cada pregunta contará con 5 opciones de respuesta, no existe respuesta correcta o incorrecta.

En caso exista alguna duda durante el proceso, podrá hacer cualquier pregunta al investigador, quien aclarará cualquier inquietud relacionada a la investigación

Si decide retirarse por algún motivo, tiene la libertad de hacerlo en cualquier momento.

- Beneficios:

El beneficio que se obtendrá por participar del presente estudio no será directamente para usted, sin embargo, le permitirá al investigador(a) conocer la situación actual del paciente adulto frente a la consulta odontológica. A través de los resultados obtenidos de este estudio permitirán conocer el nivel de ansiedad dental en pacientes adultos frente a la atención odontológica en el centro de Salud Chacra Colorada permitiendo concientizar a los odontólogos sobre cuál es su actitud en dichas circunstancias.

-Riesgos:

Usted no estará expuesto(a) a ningún tipo de riesgo en el presente estudio.

- Costos e incentivos:

Usted no deberá de pagar nada al participar en este estudio. De igual manera, no recibirá un incentivo económico ni de otra índole por su participación.

-Confidencialidad:

Toda opinión o información que Ud. entregue será tratada confidencialmente. Su identidad no será revelada. Al presentar los resultados de esta investigación no serán utilizados sus datos, o respuestas que permitan individualizarlo. La información será resguardada en un archivo

digital protegido con contraseña y sólo será usada para la presente investigación.

-Derechos del participante:

Su participación es completamente voluntaria. Se puede retirar del estudio en el momento que estime conveniente sin que ello le ocasione perjuicio alguno. Ante cualquier duda o inquietud puede contactarse con el investigador responsable la Srta. Maria del Rosario Torres Peña
Email: maria.torres28@unmsm.edu.pe Celular: 924786208

-Datos de Contacto del Comité de Ética

(para preguntas sobre sus derechos como voluntarios, o si piensa que sus derechos han sido vulnerados) puede contactarse con:

Presidente del Comité de Ética: Dr. Fernando Alfonso Ortiz Culca

Dirección: German Amezaga s/n. Lima. Facultad de Odontología UNMSM

Declaración de Consentimiento

Declaro que tuve tiempo y oportunidad de hacer preguntas, las cuales fueron respondidas a satisfacción, que no he sido coaccionado, ni influido indebidamente a participar o continuar participando en el estudio y que finalmente acepto voluntariamente participar en el estudio.

Nombres y apellidos del participante
(todo escrito con puño y letra del voluntario)

lugar y fecha FIRMA

Nombres y apellidos de persona a cargo
Del proceso de consentimiento

lugar y fecha FIRMA

Certifico que he recibido una copia del Consentimiento informado

FIRMA DEL PARTICIPANTE

I. Datos generales

Responda en los espacios en blanco según la pregunta y marque con “X” en el paréntesis donde corresponda:

1. Edad
 - () 18 – 39 años
 - () 40 años a más
2. Sexo
 - () Femenino
 - () Masculino
3. Grado de instrucción:
 - () Primaria
 - () Secundaria completa
 - () Secundaria incompleta
 - () Superior no universitaria
 - () Superior universitaria

II. Datos específicos

CUESTIONARIO ESCALA SDAI (ESCALA DE ANSIEDAD DENTAL VERSION CORTA:

Para cada una de las preguntas, por favor coloque una **X** en la casilla situada junto a la respuesta que describe mejor su experiencia frente a la atención odontológica.

PREGUNTAS	Nunca	Pocas veces	Algunas veces	Muy frecuentemente	Siempre
1. Comienzo a ponerme nervioso/a cuando el odontólogo me invita a sentarme en la silla.					
2. Cuando yo sé que el odontólogo va a extraerme un diente, me siento realmente asustado en la sala de espera.					
3. Cuando voy en camino al consultorio del odontólogo y pienso en el sonido de la fresa, me dan ganas de devolverme y no ir.					
4. Quiero irme del consultorio cuando pienso que el odontólogo no me va a explicar lo que hará en mis dientes.					
5. En el momento en que el odontólogo alista la jeringa con la inyección de anestesia, yo cierro mis ojos fuertemente.					
6. En la sala de espera sudo y tiemblo cuando pienso que es mi turno de pasar a la consulta.					
7. Cuando voy hacia el consultorio del odontólogo, me pongo ansiosa solo de pensar si tendrá que usar la fresa conmigo.					
8. Cuando estoy sentada en la silla de tratamiento y no sé lo que el odontólogo está haciendo en mi boca, me pongo nervioso/a y sudo.					
9. En mi camino hacia el consultorio del odontólogo, la idea de estar sentada en la silla de tratamiento me pone nervioso.					



Firmado digitalmente por WATANABE
VELASQUEZ Romel Armando FAJ
20140302282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.12.2024 11:58:43 -0500

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Universidad del Perú. Decana de América
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
DECANATO

Lima, 18 de Diciembre del 2024

CARTA DE PRESENTACIÓN N° 000060-2024-D-FO/UNMSM

Doctora

Delia Florencia Dávila Vigil

Directora General

DIRECCIÓN DE REDES INTEGRADAS DE SALUD DIRIS LIMA CENTRO

Presente. -

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez, presentar a la Br. **MARIA DEL ROSARIO TORRES PEÑA** identificada con DNI n.° 75595300, de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Marcos, quien se encuentra desarrollando la tesis titulada: "NIVEL DE ANSIEDAD EN ADULTOS FRENTE A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN EL CENTRO DE SALUD CHACRA COLORADA - LIMA".

Al respecto, la mencionada bachiller desea ejecutar su proyecto de tesis en el C.S. Chacra Colorada que está bajo la jurisdicción de la Diris Lima Centro, institución que usted tan dignamente dirige.

Por tal motivo, solicito respetuosamente a su despacho que gestione la autorización ante el centro de salud mencionado para que la Br. **MARIA DEL ROSARIO TORRES PEÑA** realice la recolección de datos para su trabajo de investigación.

Agradeciendo su amable atención, me despido a siendo propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Dr. Romel Armando Watanabe Velásquez

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA



RWV/pcs

